

INFORME DE EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA

— Variante Profesional —

PACIENTE

Elena Rosa Cardona Restrepo

DOCUMENTO

CC 41789456

FECHA NACIMIENTO

01/01/1945

EDAD

81 años, 5 meses

SEXO

Femenino

ESCOLARIDAD

Primaria Incompleta

LATERALIDAD

Diestra

FECHA DE EVALUACIÓN

19/06/2026

ORDEN N°

OM-2026-001249

PROTOCOLO APLICADO

Neuronorma Colombia AM + MMSE + GDS-15 + Grober

INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA

Nombre:	Elena Rosa Cardona Restrepo	Lateralidad:	Diestra
Documento:	CC 41789456	Ocupación:	Agricultora (jubilada)
Fecha de nacimiento:	01/01/1945	Ciudad:	Sonsón, Antioquia
Edad:	81 años, 5 meses	Acompañante:	Juan David Cardona Henao
Sexo:	Femenino	Remite:	Médico familiar
Escolaridad:	Primaria Incompleta	EPS / Asegurador:	Sura EPS

MOTIVO DE CONSULTA

Pérdida de memoria progresiva de 3 años. Desorientación temporal, repite historias, dificultad para cocinar y manejar dinero. No reconoce ocasionalmente a nietos. MMSE 22/30 en consulta previa.

PRUEBAS APLICADAS

Protocolo: Neuronorma Colombia AM + MMSE + GDS-15 + Grober

Prueba	Dominio	Dur.
TMT A	Atención	—
TMT B	Funciones Ejecutivas	—
Span Retención Dígitos Directo	Memoria de Trabajo	—
Span Retención Dígitos Inverso	Memoria de Trabajo	—
Test de Stroop Palabra	Atención	—
Test de Stroop Color	Atención	—
Test de Stroop Palabra/Color	Atención	—
Fluidez Verbal Animales	Lenguaje - Fluidez	—
Fluidez Verbal Fonémica (P)	Lenguaje	—
AM Deno	Lenguaje	—
Grober RL Ensayo 1 (libre)	General	—
Grober RLT - Retención Libre Total (E1+E2+E3)	General	—
Grober RT - Recuerdo Total Claves (E1+E2+E3)	General	—
Escala de Depresión Geriátrica Yesavage	Socioemocional - Depresión	—
Mini-Mental State Examination (MMSE)	General	—
Escala de Lawton y Brody (IADL)	General	—

ANTECEDENTES

Patológicos / Médicos

Sin antecedentes médicos de relevancia.

Farmacológicos

Sin medicación actual.

Familiares

Sin antecedentes neuropsiquiátricos de primer grado.

Psiquiátricos

Antecedente de trastorno depresivo en tratamiento con sertralina 50 mg/día.

Traumáticos

Niega TEC.

RESUMEN EJECUTIVO

Pirámide invertida: conclusión, hallazgos, implicación

Conclusión

Perfil neuropsicológico global: $Z = -0.8\sigma$ sobre 6 dominios evaluados.

Hallazgos clave

- General moderadamente descendido ($Z = -1.6\sigma$)

Implicación

Se sugiere intervención dirigida al dominio descendido, con monitoreo de respuesta a tratamiento.

OBSERVACIÓN CLÍNICA

Hallazgos cualitativos durante la administración

Apariencia y conducta

Evaluación neuropsicológica completa. Paciente colaborador. Sin incidentes durante la aplicación.

Memoria

Déficit severo en memoria episódica anterógrada. No retiene información tras distractores. Memoria remota parcialmente preservada (hechos antiguos).

Praxias y gnosias

Sin alteraciones significativas en praxias ni gnosias.

Lenguaje

Anomia moderada. Parafasias semánticas. Comprensión de órdenes complejas descendida. Fluidez muy descendida.

Cociente intelectual (observación)

Perfil cognitivo global: G30.0 - Enfermedad de Alzheimer de inicio temprano (leve)

RESULTADOS CUANTITATIVOS

Puntajes por prueba y perfil cognitivo del paciente

Escala de Depres

5

Normal

Mini-Mental Stat

21

Deficit Leve

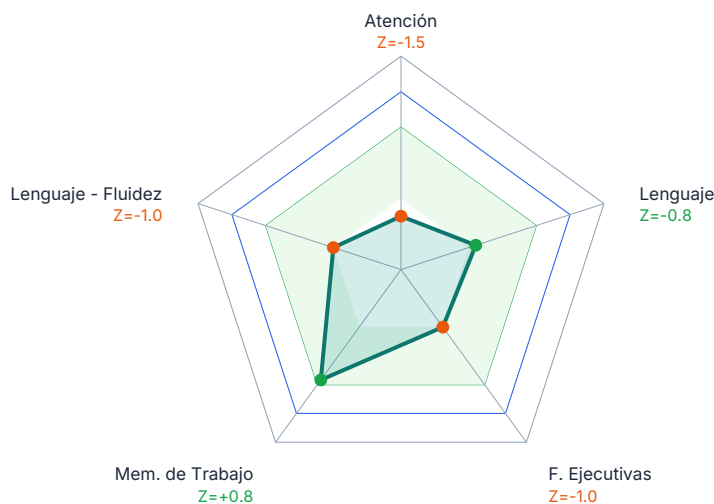
Escala de Lawton

4

Deficit Extremo

Perfil cognitivo por dominio

Cada eje representa un dominio cognitivo. El polígono teal muestra el Z del paciente; la franja verde central equivale al rango normal (-1 a +1 σ).

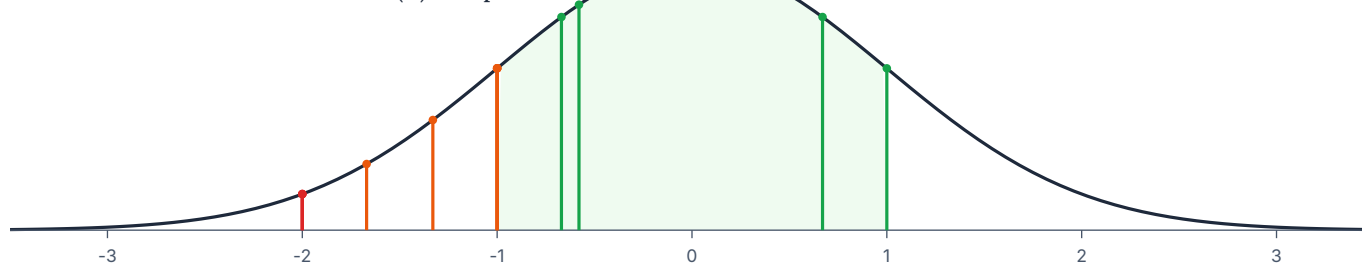


Curva normal con puntajes Z del paciente

Eje horizontal: puntaje Z (unidades de desviación estándar). Las marcas rojas son los puntajes del paciente sobre la curva.

Distribución del rendimiento (Z) del paciente sobre la curva normal estándar

n = 13 pruebas con norma disponible

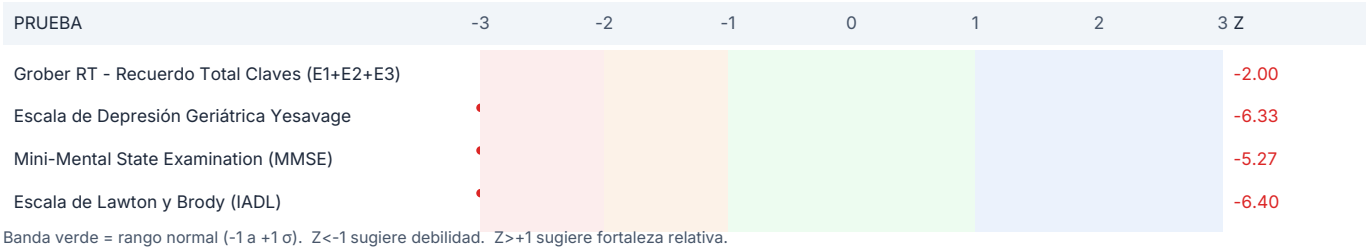


Perfil Z por prueba

Perfil Z por prueba

Eje horizontal: puntaje Z (rango -3 a +3). Verde = zona normal; rojo/naranja = debajo del promedio; azul = por encima.

PRUEBA	-3	-2	-1	0	1	2	3 Z
TMT A							-1.00
TMT B							-1.00
Span Retención Dígitos Directo							+1.00
Span Retención Dígitos Inverso							+0.67
Test de Stroop Palabra							-2.00
Test de Stroop Color							-1.67
Test de Stroop Palabra/Color							-1.33
Fluidez Verbal Animales							-1.00
Fluidez Verbal Fonémica (P)							-1.00
AM Deno							-0.58
Grober RL Ensayo 1 (libre)							-2.00
Grober RLT - Retención Libre Total (E1+E2+E3)							-0.67



Semáforo de dominios cognitivos

DOMINIO	Z	BANDA
General	-1.56σ	moderado
Atención	-1.50σ	moderado
Funciones Ejecutivas	-1.00σ	moderado
Lenguaje - Fluidez	-1.00σ	moderado
Lenguaje	-0.79σ	promedio
Memoria de Trabajo	+0.83σ	promedio

Tabla detallada de puntajes

Prueba	PD	Escalar/CI	Z	Interpretación
TMT A	182	7	-1.00	Promedio
TMT B	322	7	-1.00	Promedio
Span Retención Dígitos Directo	5	13	+1.00	Superior
Span Retención Dígitos Inverso	3	12	+0.67	Promedio
Test de Stroop Palabra	30	4	-2.00	Bajo
Test de Stroop Color	23	5	-1.67	Límitrofe
Test de Stroop Palabra/Color	9	6	-1.33	Límitrofe
Fluidez Verbal Animales	8	7	-1.00	Promedio
Fluidez Verbal Fonémica (P)	6	7	-1.00	Promedio
AM Deno	28	28	-0.58	Promedio
Grober RL Ensayo 1 (libre)	4	4	-2.00	Bajo
Grober RLT - Retención Libre Total (E1+E2+E3)	5	8	-0.67	Promedio
Grober RT - Recuerdo Total Claves (E1+E2+E3)	7	4	-2.00	Bajo
Escala de Depresión Geriátrica Yesavage	5	5	-6.33	Normal
Mini-Mental State Examination (MMSE)	21	21	-5.27	Deficit Leve
Escala de Lawton y Brody (IADL)	4	4	-6.40	Deficit Extremo

SÍNTESIS CLÍNICA INTEGRADORA

Lectura cuantitativa de los hallazgos

El perfil neuropsicológico evidencia debilidades en: general (moderadamente disminuido, Z=-1.6); atención (moderadamente disminuido, Z=-1.5); funciones ejecutivas (moderadamente disminuido, Z=-1.0); lenguaje - fluidez (moderadamente disminuido, Z=-1.0).

Entre las pruebas con mayor desviación se encuentran Test de Stroop Palabra (Z=-2.00, bajo); Grober RL Ensayo 1 (libre) (Z=-2.00, bajo); Grober RT - Recuerdo Total Claves (E1+E2+E3) (Z=-2.00, bajo). Estos hallazgos orientan la formulación diagnóstica y la priorización de objetivos de intervención.

Áreas con desempeño disminuido

- Grober RL Ensayo 1 (libre) — bajo ($Z=-2.00$)
- Grober RT - Recuerdo Total Claves (E1+E2+E3) — bajo ($Z=-2.00$)
- Test de Stroop Palabra — bajo ($Z=-2.00$)
- Test de Stroop Color — límite ($Z=-1.67$)
- Test de Stroop Palabra/Color — límite ($Z=-1.33$)
- Fluidez Verbal Animales — promedio ($Z=-1.00$)

Áreas con desempeño preservado / superior

- Span Retención Dígitos Directo — superior ($Z=+1.00$)

RESUMEN PARA LA FAMILIA

Lenguaje sencillo para padres, cuidadores y paciente

Saludo

Este es un resumen de la evaluación que se realizó Elena. Está escrito en un lenguaje sencillo para que sea fácil de entender. Tu psicólogo o psicóloga te explicará los detalles y resolverá cualquier duda que tengas.

¿Qué hicimos en la evaluación?

Realizamos varias pruebas que miden cómo funciona tu cerebro en distintas situaciones: memoria, atención, lenguaje, razonamiento y la velocidad con la que procesas información. Las pruebas son como "pequeños retos" que se resuelven con papel, lápiz y a veces con cubos o figuras. No hay respuestas buenas ni malas: lo que nos interesa es conocer cómo trabaja tu mente.

¿Qué encontramos?

Las áreas donde te fue bien incluyen: En TMT A, tu rendimiento fue dentro del rango esperado. En TMT B, tu rendimiento fue dentro del rango esperado. En Span Retención Dígitos Directo, tu rendimiento fue muy por encima del promedio. Las áreas donde se recomienda trabajar incluyen: En Test de Stroop Palabra, encontramos un rendimiento por debajo del promedio. Es importante que converses con tu psicólogo/a sobre qué significa esto y qué apoyos podrían ayudarte. En Test de Stroop Color, tu rendimiento estuvo en el límite (Límitrofe). Vale la pena acompañarlo de cerca. En Test de Stroop Palabra/Color, tu rendimiento estuvo en el límite (Límitrofe). Vale la pena acompañarlo de cerca.

Implicaciones para la vida diaria

Además de los puntajes, esto es lo que podría notarse en la vida cotidiana:

General · moderado

- Tareas que dependen de esta función pueden requerir más esfuerzo o tiempo.
- Rendimiento bajo comparado con pares de la misma edad y escolaridad.

Apoyos sugeridos: Practicar con constancia y paciencia. · Acompañar el proceso con apoyo profesional y familiar.

Atención · moderado

- Mantener el foco en una conversación larga (especialmente en reuniones o clases).
- Seguir instrucciones de varios pasos sin perder algún detalle.
- Filtrar estímulos distractores en lugares ruidosos o con mucha gente.

Apoyos sugeridos: Dividir el trabajo en bloques de 20-25 minutos con pausas activas. · Usar temporizadores visuales (Time Timer) y listas de verificación.

Funciones Ejecutivas · moderado

- Planear y organizar actividades que requieren varios pasos (cocinar, viaje, proyecto).
- Iniciar una tarea que no es agradable pero necesaria.
- Adaptarse a cambios de planes o situaciones inesperadas.

Apoyos sugeridos: Dividir metas grandes en mini-metas con fechas claras. · Usar agenda, alarmas y recordatorios del celular.

Lenguaje - Fluidez · moderado

- Tareas que dependen de esta función pueden requerir más esfuerzo o tiempo.
- Rendimiento bajo comparado con pares de la misma edad y escolaridad.

Apoyos sugeridos: Practicar con constancia y paciencia. · Acompañar el proceso con apoyo profesional y familiar.

Áreas para apoyar (en qué trabajar)

- En TMT A, tu rendimiento fue dentro del rango esperado.
- En TMT B, tu rendimiento fue dentro del rango esperado.
- En Span Retención Dígitos Directo, tu rendimiento fue muy por encima del promedio.
- En Span Retención Dígitos Inverso, tu rendimiento fue dentro del rango esperado.
- En Fluidez Verbal Animales, tu rendimiento fue dentro del rango esperado.
- En Test de Stroop Palabra, encontramos un rendimiento por debajo del promedio. Es importante que converses con tu psicólogo/a sobre qué significa esto y qué apoyos podrían ayudarte.
- En Test de Stroop Color, tu rendimiento estuvo en el límite (Límitrofe). Vale la pena acompañarlo de cerca.
- En Test de Stroop Palabra/Color, tu rendimiento estuvo en el límite (Límitrofe). Vale la pena acompañarlo de cerca.
- En Grober RL Ensayo 1 (libre), encontramos un rendimiento por debajo del promedio. Es importante que converses con tu psicólogo/a sobre qué significa esto y qué apoyos podrían ayudarte.
- En Grober RT - Recuerdo Total Claves (E1+E2+E3), encontramos un rendimiento por debajo del promedio. Es importante que converses con tu psicólogo/a sobre qué significa esto y qué apoyos podrían ayudarte.

¿Qué recomendamos?

Sobre la terapia: continúa con tus sesiones según lo acordado. Si tienes dudas, coméntalas con tu terapeuta.

Preguntas frecuentes

¿Mis resultados son permanentes?

No necesariamente. El cerebro puede cambiar con el tiempo, especialmente con práctica, con los apoyos adecuados y con un buen ambiente. Estos resultados son una foto del momento actual: tu psicólogo/a te ayudará a entender qué puede cambiar y qué se mantiene más estable.

¿Por qué algunos resultados son mejores que otros?

Es completamente normal. Todas las personas tienen áreas donde son más fuertes y áreas donde pueden mejorar. Esto NO significa que haya algo mal: el cerebro humano es diverso y cada uno tiene su propio perfil.

¿Qué significa un puntaje 'bajo' o 'muy bajo'?

Significa que, comparado con personas de la misma edad y nivel educativo, esa función específica rindió por debajo de lo esperado. NO es un diagnóstico en sí mismo. Es una señal para profundizar, entrenar y apoyar esa área. Tu psicólogo/a te explicará si requiere intervención profesional adicional.

¿Qué es el 'cociente intelectual' (CI)?

El CI es un número que resume el rendimiento global en diversas pruebas. NO define tu inteligencia total ni tu valor como persona: es solo una medida parcial de ciertas habilidades de razonamiento, memoria y atención. Varía según el contexto, la fatiga, el ánimo del día y muchos otros factores.

¿Qué hago con las áreas donde me fue muy bien?

¡Celebra y potencia esas fortalezas! Pueden ser tu ancla para compensar las áreas que requieren más esfuerzo. Compartir esto con tu familia, colegio o terapeuta les permite diseñar estrategias que aprovechen lo que mejor te sale.

IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA

DSM-5 / CIE-10

Diagnóstico codificado

Código CIE-10: G30

Impresión diagnóstica: G30.0 - Enfermedad de Alzheimer de inicio temprano (leve)

RECOMENDACIONES

Plan de manejo agrupado por área y prioridad

- Se recomienda seguimiento clínico y plan terapéutico según hallazgos. Reevaluación en 6-12 meses si aplica.

Recomendaciones del cuadro clínico

Banco de recomendaciones clínicas sugeridas para el cuadro identificado. El clínico debe seleccionar las aplicables antes de emitir el informe definitivo.

Deterioro cognitivo leve amnésico (F067) — sospecha de EA prodrómica · Adulto Mayor (50+ años)

- Valoración por neurología para caracterización etiológica (biomarcadores si aplica).
- Programa de estimulación cognitiva estructurado 2-3 veces por semana.
- Terapia de reminiscencia y orientación a la realidad.
- Ejercicio físico aeróbico regular (caminatas de 30 min/día).
- Dieta MIND o mediterránea.
- Control estricto de factores de riesgo vascular.
- Higiene del sueño y tratamiento de apnea del sueño si aplica.
- Actividades de socialización estructurada — prevenir aislamiento.

ANEXO — DEFINICIONES OPERATIVAS

Convenciones interpretativas utilizadas en este informe

Cociente Intelectual (CI)

Puntuación estándar con media 100 y desviación 15. CIT menor a 70 sugiere déficit; 70-79 límite; 80-89 promedio bajo; 90-109 promedio; 110-119 promedio alto; 120-129 superior; ≥ 130 muy superior.

Puntaje escalar (PE)

Subtests Wechsler — media 10, desviación 3. PE de 8-12 equivale al rango promedio.

Puntuación Z

Desvío en unidades de desviación estándar respecto al grupo normativo. $Z = (PD - \mu) / \sigma$. $Z \leq -1$ indica rendimiento bajo el promedio; $Z \leq -2$ indica déficit clínico.

Percentil

Porcentaje de la población normativa con desempeño igual o inferior al del paciente.

Discrepancia significativa

Diferencia entre índices que excede el umbral de Wechsler. Líneas críticas: $p < .15$ (.....) sugieren tendencia; $p < .05$ () indican diferencia confiable.

Reliable Change Index (RCI)

Jacobson-Truax. $RCI > 1.96$ indica cambio confiable ($p < .05$) entre evaluaciones repetidas. Se reporta sólo en informes de seguimiento.

Glosario: palabras técnicas que usamos

Definiciones operativas de los términos técnicos utilizados en este informe.

CI / CIT

Cociente Intelectual Total. Medida global del funcionamiento intelectual con media 100 y desviación 15. Rango normal: 90-109. < 70 : déficit; 70-79: límite; 80-89: promedio bajo; 110-119: promedio alto; 120-129: superior; ≥ 130 : muy superior.